

旅遊醫學門診之實務

臺大醫院 家庭醫學部 李怡萱 程劭儀

前言

根據交通部觀光局的國人出國目的地人數統計¹，2013年出國人數總計約1,105萬人次，其中造訪亞洲約占93.99%，以大陸港澳占最多比例，東北亞國家次之。除此之外，前往中南美洲及非洲的人次小於0.1%；前往非洲則占0.2%。上述這些地區旅遊風險較高且醫療水準參差不齊，旅遊行前醫療諮詢相當重要；然而我國出國民眾會在旅遊前尋求健康諮詢之比例雖有逐年增加，但依然遠低於歐美國家。隨著旅遊的普及與發達，因旅行導致的各項健康問題不容小覷，如傳染性疾病與極端環境(如高海拔區域)對健康的影響等。

台灣位處東亞，是東西方交通集散地，來往旅客相當多；偶有法定傳染病由鄰近國家來台的旅客以及工作者帶入，境外移入傳染病亦時有所聞。根據疾管署的統計²，2013年境外移入確定病例數為715例；前三位分別為登革熱(260例)；阿米巴痢疾(181例)；桿菌性痢疾(128例)。防疫無國界，除了主責機關擔負防疫的重任，如何增進民眾對相關疾病的認識，並讓更多醫護專業人員參與相關工作，都成了未來要努力的方向。

自2013年7月確認狂犬病台灣本土動物病例後，狂犬病暴露後疫苗接種對象已不再僅限於在國外疫區遭受溫血哺乳類動物抓、咬傷的民眾。於台灣被野生哺乳類動物、流浪犬貓抓、咬傷，或傷口、黏膜接觸其唾液等分泌物的民眾，也建議就醫並接種疫苗。罹患狂犬病並發病之死亡率接近100%，鄰近台灣的中國大陸及印度為亞洲狂犬病死亡人數最高的國

家。亦身處狂犬病疫區的台灣，民眾及醫護人員皆須對狂犬病有更多的認識。

近幾年，國人旅遊地點及目的，以及旅遊族群的年齡和健康情形的多變性與以往有很大差別。再加上全球人口移動帶來公衛健康問題，以及傳染病流行瞬息萬變等因素，旅遊醫學的重要性不容忽視。

旅遊民眾的行前醫療諮詢

旅遊醫學門診醫師的責任，在於針對民眾做個人化的風險評估，給予醫療的建議。需考量的旅遊資料如下：民眾過去的疫苗接種紀錄、旅遊行程內容（當地的公共衛生概況和即時疫情）、地區停留天數、旅遊型態（如商務或自助旅行、都市或鄉下地區旅行）、住宿與旅遊活動（如登山、潛水）等項目。需特別注意的是，脫離常規路線的旅行，如自助旅行、長期旅行等，都是旅遊的高危險群。

有些疫苗是要在出國前預先施打的，且大多數疫苗在打完以後一段時間，才能在身體產生有效的免疫反應。因此，若欲轉介即將前往衛生條件相對不足的地區旅遊的民眾至旅遊醫學門診就診，可提醒民眾在行程出發前至少兩個禮拜求診，進行專業的評估、必要的檢驗及醫療諮詢。

旅行前的預防接種³

旅行前的預防接種，依接種時機及目的不同，主要分為三類：

- 一、強制性疫苗接種（mandatory vaccination）或必須性疫苗接種（required vaccination）

目前世界衛生組織實際規定必須接種的強制性疫苗只有黃熱病疫苗一項，欲入境部份撒哈拉以南之非洲地區和熱帶南美洲一些國家，需持疫苗接種證明(黃皮書)入境。沙烏地阿拉伯規定朝聖者必須接種腦膜炎雙球菌疫苗；欲前往中非流行性腦膜炎流行區(meningitis belt)的旅客，則為建議接種。另外有些國家如沙烏地阿拉伯規定來自小兒麻痺流行國家(如阿富汗、印度、奈及利亞以及巴基斯坦)的旅遊者需完成小兒麻痺疫苗接種。

黃熱病疫苗以及流行性腦脊髓膜炎疫苗，需要在至少十天前至疾管署國際預防接種合作計畫的醫院接種，其效期分別為10年(黃熱病疫苗)與3年(流行性腦膜炎疫苗)。

二、選擇性疫苗接種 (selective use of vaccination) 或建議性疫苗接種 (recommended vaccination)

指的是未包含在例行性接種疫苗內，依旅遊地點的傳染病流行情況及旅遊者行程、活動內容評估風險的高低，來建議是否施打的疫苗。

旅遊者選擇性疫苗接種包括有A型肝炎疫苗、狂犬病疫苗、流行性腦脊髓膜炎疫苗、日本腦炎疫苗、傷寒疫苗等。狂犬病疫苗、流行性腦脊髓膜炎疫苗、傷寒疫苗，需要到疾管署國際預防接種合作計畫的醫院接種。其他如A型肝炎等疫苗可就近至各大醫院注射疫苗。

三、例行性疫苗接種 (routine vaccination)

每個國家例行性疫苗接種的建議種類及時間，會隨各國傳染性疾病的流行情況而有些

許的不同。旅遊醫學門診醫師會依民眾過去接種疫苗的記錄，以及旅遊地點的傳染病流行現況，來建議是否需要追加疫苗。

旅行前的預防用藥

一、瘧疾預防用藥⁴

瘧疾在很多熱帶和亞熱帶地區是常見，且有生命威脅的疾病。台灣自1965年經WHO宣佈為瘧疾根除地區之後，是亞洲少數沒有瘧疾流行的地區之一。但是，近年來國人不論是從事觀光，或是宗教的旅遊活動，造訪瘧疾流行區的機會與日俱增。大部分境外移入病例來自東南亞地區、非洲、中南美洲和大洋洲。

出外的旅客，如果未能在行前得到有效預防瘧疾的方式，而在境外想要尋求醫療協助，可能困難重重；從瘧疾流行區返國的旅客，如果染上瘧疾發病，可能因此而致死。有鑑於此，應建議民眾至少在出國前兩週以上，至疾管署國際預防接種合作計畫的醫院接受旅遊前諮詢，目前藥物的使用仍是瘧疾預防的主力。然而要謹記的是，沒有任何的預防性藥物，可以提供100%的保護，但是好的預防性投藥，卻可以減低致命性感染的風險。

常見的瘧疾預防性藥物，主要有四種，分別為Chloroquine, Mefloquine, Atovaquone/Proguanil(Malarone), Doxycycline。藥物的選擇需由醫師根據旅遊地點、出發時間、停留天數，以及民眾個人健康(如過去病史、過敏史、是否有懷孕等)情況做建議。有需求的民眾可轉介至旅遊醫學門診諮詢。

二、高海拔疾病預防用藥⁵

在海拔高度2500公尺以上就有可能發生高海拔疾病；隨著高度越高，出現症狀的比例就越高。其導因於高海拔地區氧氣濃度與壓力較低，身體為增加腦部及肺部的氧氣，會將血管擴張以增加血流量；當血管擴張過快時，導致微血管內水分快速散失至身體組織間，而出現腦水腫及肺水腫。高海拔疾病可分三種：急性高山症、高山腦水腫及高山肺水腫，後兩者為急症，需緊急醫療處理。

台灣有200座海拔3000公尺以上的高山，玉山的主峰更高達將近4000公尺，每年有近500萬人次在國內進行登山活動。而國外熱門的旅遊景點中，青藏鐵路有85%以上的軌道高於4000公尺；中南美洲秘魯印加遺址庫斯科、馬丘比丘亦高達3000公尺。民眾在從事登山活動或在高海拔地區旅遊前，一定要了解高山症及其致命的症狀。

在預防藥物方面，具有利尿劑作用的丹木斯（Acetazolamide, Diamox）證實可有效預防及降低急性高山症，對丹木斯不耐受的人（如對磺胺類藥物過敏），可使用類固醇（Dexamethasone）來預防急性高山症。高山腦水腫可用類固醇來預防。至於高山肺水腫的預防藥物則是鈣離子阻斷劑（Nifedipine）以及威而剛（Sildenafil, Viagra）／犀利士（Tadalafil, Cialis）這類藥物。使用時機建議在登高前24小時服用，一直使用到不再登高後2到3天。出發前建議民眾前往旅遊醫學門診諮詢藥物的使用。至於其他療法，如西藏的紅景天、南美洲當地販賣的菸草等，其療效作用仍不明。

旅遊醫學門診實務內容

目前全台與疾管署合約的醫院共有23家（表1）⁶，旅遊醫學門診一律為「自費」門診。

表1 旅遊醫學合約醫院

縣市	醫療機構名稱	看診科別
基隆市	衛生福利部基隆醫院	家庭醫學科
臺北市	馬偕紀念醫院(臺北院區)	家庭醫學科
	國立臺灣大學醫學院附設醫院	家庭醫學科
	三軍總醫院(內湖院區)	旅遊醫學門診
新北市	亞東紀念醫院	家庭醫學科
宜蘭縣	羅東聖母醫院	家庭醫學科
桃園縣	壠新醫院桃園國際機場	
	醫療中心診所	
新竹市	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院	家庭醫學科
新竹縣	東元綜合醫院	家庭醫學科、 感染科
苗栗縣	衛生福利部苗栗醫院	家庭醫學科
臺中市	衛生福利部臺中醫院	家庭醫學科
	童綜合醫院	家庭醫學科
彰化縣	彰化基督教醫院	家庭醫學科
南投縣	埔里基督教醫院	感染科
雲林縣	國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	家庭醫學科
嘉義市	天主教聖馬爾定醫院	健康檢查中心
嘉義縣	嘉義長庚紀念醫院	家庭醫學科
臺南市	國立成功大學醫學院附設醫院	家庭醫學科
高雄市	高雄市立小港醫院	家庭醫學科
	高雄市立聯合醫院	小兒科
屏東縣	屏東基督教醫院	家庭醫學科
花蓮縣	衛生福利部花蓮醫院	家庭醫學科、 內科
臺東縣	衛生福利部臺東醫院	家庭醫學科

旅遊醫學門診提供的服務有：

1. 旅行目的地傳染病風險專業評估。
2. 疫苗接種與證明。
3. 瘧疾預防用藥或其他常備藥物。
4. 自我防護健康衛教資訊。
5. 攜帶處方藥物或尖銳醫療器材（如糖尿病胰島素注射針等）之醫療證明文件。
6. 個人慢性疾病旅遊風險評估與諮詢。

藉由旅行前的醫療規畫，讓民眾在出國遊玩的同時，也能同時兼顧對健康的需求。

參考文獻

1. 交通部觀光局97年至102中華民國國民出國目的地人數統計。
2. 衛生福利部疾病管制署疫情監測速訊2013。
3. Kroger AT, Strikas RA: Gernal Recommendations for Vaccination & Immunoprophylaxis. Gary W. Brunette. CDC Health Information for International Travel 2014. Oxford University Press. New York. USA. P.37-49.
4. Arguin PM, Tan KR: Malaria. Gary W. Brunette. CDC Health Information for International Travel 2014. Oxford University Press. New York.USA.P.228-45.
5. Hackett PH, Shlim DR: Altitude Illness. Gary W. Brunette. CDC Health Information for International Travel 2014. Oxford University Press. New York.USA. P.65-9.

6. 衛生福利部疾病管制署 旅遊醫學合約醫院據點(2014年6月27日更新) 

